

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5065167-64.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARINA DE OLIVEIRA E SILVA

RECORRENTE: SEVERINA ANTONIA PEREIRA

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

MEDIDA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE INDEFERIU O REQUERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO EM FACE DE DECISÃO RETRÔ. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO ATIVO A TAL RECURSO. PEDIDO DE “EXAME DE MAMOGRAFIA, COM INDICAÇÃO DE “MAMOGRAFIA DIAGNÓSTICA EM AMBAS AS MAMAS”, SOB A ALEGAÇÃO DE MOLÉSTIA GRAVE, “NEOPLASIA MALIGNA DA MAMA”. PARECER DO NAT CONTRÁRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso e ratifico a decisão que indeferiu a liminar, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2024.

5065167-64.2024.4.02.5101

510014531194 .V10

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5065167-64.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARINA DE OLIVEIRA E SILVA

RECORRENTE: SEVERINA ANTONIA PEREIRA

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência, com pedido de liminar, na qual **SEVERINA ANTONIA PEREIRA**, objetivando atribuir efeito suspensivo ativo da decisão interlocutória que indeferiu a antecipação da tutela provisória de urgência, por meio da qual a parte pleiteia a urgência quanto ao “*exame de mamografia, com indicação de “mamografia diagnóstica em ambas as mamas”*”, em face da UNIÃO FEDERAL, do ESTADO DO RIO DE JANEIRO e do MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, sob a alegação de doença grave, “neoplasia maligna da mama” (Evento 1, INIC/ Evento 1, ANEXO2, pag. 11)

É o breve relatório.

VOTO

Pois bem, no caso em tela não houve modificação do contexto fático-probatório capaz de alterar o entendimento proferido na decisão (Evento 16, DESPADEC1), a qual passa a integrar o presente voto:

“DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de medida de urgência interposta em face da decisão proferida no processo 5064382-05.2024.4.02.5101/RJ, evento 4, DESPADEC1:

Trata-se de ação pelo rito sumaríssimo ajuizada por **SEVERINA ANTONIA PEREIRA** em face da **UNIÃO, ESTADO DO RIO DE JANEIRO e MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO**, objetivando, inclusive em sede de tutela de urgência, a realização de exame de mamografia bilateral para rastreamento.

Do pedido de Tutela de Urgência.

Analisando os autos, observo que, a despeito da argumentação autoral, não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, sendo necessária ao menos a formação do contraditório para que, assim, a parte ré possa esclarecer os fatos narrados na inicial.

De outra sorte, tampouco se verifica presente o risco de dano irreparável, também suprido pelo caráter célere do rito no Juizado Especial, pois somente se concebe a concessão de medidas tutelares em hipóteses excepcionais, nos termos do art. 4º da Lei nº 10.259/01, estando ausente o periculum in mora.

Note-se que, a despeito da juntada do pedido médico relativo ao exame postulado (Evento 1, ANEXO2, fls. 9/10), não há nos autos prova médica que justifique a urgência em sua realização. Além disso, não foi esclarecido pela parte autora os motivos de eventual recusa do INCA na realização do exame, bem como não foi sequer localizada a necessária regulação da parte autora junto ao SER ou SISREG para realização do exame (Evento 3).

Assim, neste cenário inicial, mostra-se prematura a concessão da tutela requerida, ainda mais porque a pretensão de urgência poderá ser analisada após o contraditório.

Isto posto, **indefiro por ora a tutela de urgência requerida.**

DEFIRO a gratuidade de justiça requerida, diante dos documentos acostados ao Evento 1, ANEXO2, fl. 4/7, bem como diante do patrocínio pela Defensoria Pública da União.

Da citação e ações administrativas

Cumprido, cite-se a parte ré para, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, oferecer resposta. Na mesma oportunidade, intime-se a parte ré para, em igual prazo, manifestar-se sobre a possibilidade de conciliação, bem como fornecer a este juízo toda a documentação de que disponha para o esclarecimento dos fatos trazidos à apreciação do Poder Judiciário, nos termos do art. 11 da Lei nº 10.259/2001, em especial, as informações administrativas específicas para o caso concreto.

Desde já, **resta preventivamente indeferido de plano pedido de dilação de prazo** para a apresentação dos documentos de defesa e das informações administrativas acima referidas bem como requerimento no sentido de que o órgão administrativo responsável pelo fornecimento da mencionada documentação seja diretamente oficiado por este Juízo, cabendo à parte ré, dentro do razoável prazo de 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS, legalmente estabelecido, o encargo quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Expeça-se ofício ao INCA III para que informe nos autos, no prazo de 15 dias, o motivo da não realização do exame de mamografia requerido, bem como da não regulação da paciente junto ao SER ou SISREG para solicitação do exame.

Apresentada a contestação ou decorrido in albis o prazo, intem-se as partes para, em 05 dias úteis comuns, indicarem, de modo específico e fundamentado, as provas adicionais que pretendem produzir, com indicação de cada fato que pretendem demonstrar com cada prova ou diligência probatória postulada. Nessa oportunidade, a parte autora poderá manifestar-se sobre a contestação e/ou documentos juntados pela parte ré.

Havendo necessidade de produção de prova pericial simples, **resta previamente autorizada** a designação de perícia na especialidade pertinente, determinando à Secretaria, neste caso, que adote as providências cabíveis para a nomeação do perito responsável, agendamento da data de sua realização e intimação das partes.

Cumprido, venham-me os autos conclusos para sentença.

É o breve relatório.

Sabe-se que são requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência: a) a probabilidade do direito pleiteado, ou seja, uma plausibilidade lógica que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, do que decorre um provável reconhecimento do direito, baseada em uma cognição sumária; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso não concedida, ou seja, quando houver uma situação de urgência em que se não se justifique aguardar o desenvolvimento natural do processo sob pena de ineficácia ou inutilidade do provimento final.

No caso, a parte autora não comprovou ambos os requisitos.

Dispõe o Enunciado 13 do CNJ: "Nas ações de saúde que pleiteiam o fornecimento de medicamentos, produtos ou tratamentos, recomenda-se, sempre que possível, a prévia oitiva do gestor do Sistema Único de Saúde - SUS, com vistas a, inclusive, identificar solicitação prévia do requerente, alternativas terapêuticas e competência do ente federado, quando aplicável (Saúde Pública e Suplementar). (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde - 18.03.2019)".

PARECER TÉCNICO/SES/SJ/NATJUS-FEDERAL Nº 1480/2024

Rio de Janeiro, 03 de setembro de 2024.

Processo nº 5065167-64.2024.4.02.5101,
ajuizado por **Severina Antonia Pereira**.

Inicialmente cabe esclarecer que, para a emissão do presente parecer técnico, foram analisados os documentos médicos anexados ao processo originário (Nº 5064382-05.2024.4.02.5101).

Trata-se de Autora, de 68 anos de idade, com diagnóstico de **câncer de mama** (Evento 1, ANEXO2, Página 11 do processo originário), sendo solicitado o exame de **mamografia diagnóstica em ambas as mamas** (Evento 1, ANEXO2, Página 9 do processo originário) **com urgência**. Foi pleiteado o exame de **mamografia bilateral** (Evento 1, INIC1, Página 5 do processo originário).

Informa-se que o exame de **mamografia bilateral** pleiteado **está indicado** para melhor elucidação diagnóstica e manejo do quadro clínico apresentado pela Autora (Evento 1, ANEXO2, Página 9 do processo originário).

Considerando o disposto na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES), informa-se que o exame pleiteado **está coberto pelo SUS**, conforme Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses/Próteses e Materiais Especiais do Sistema Único de Saúde - SUS (SIGTAP), na qual constam: mamografia (02.04.03.003-0) e mamografia bilateral para rastreamento (02.04.03.018-8).

O acesso ao serviço habilitado para o caso em tela ocorre com a inserção da demanda junto ao sistema de regulação. Cumpre salientar que a Política Nacional de Regulação, está organizada em três dimensões integradas entre si: Regulação de Sistemas de Saúde, Regulação da Atenção à Saúde e Regulação do Acesso à Assistência, que devem ser desenvolvidas de forma dinâmica e integrada, com o objetivo de apoiar a organização do sistema de saúde brasileiro, otimizar os recursos disponíveis, qualificar a atenção e o acesso da população às ações e aos serviços de saúde¹.

Ressalta-se que a Autora está sendo acompanhada por uma unidade de saúde pertencente ao SUS e integrante da Rede de Alta Complexidade Oncológica do Estado do Rio de Janeiro – **Hospital do Câncer III – INCA III** (Evento 1, ANEXO2, Páginas 9 e 11 do processo originário). Portanto, informa-se que é responsabilidade da referida instituição realizar o exame de **mamografia bilateral pleiteado** ou, no caso de impossibilidade, encaminhar a Autora à uma outra unidade de saúde apta ao atendimento da demanda. Assim como, é de sua responsabilidade fornecer a assistência integral em oncologia à Demandante.

1 BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde (PNSUS). Brasília: Ministério da Saúde, 2018.

Cabe ainda destacar que, ao Evento 13, CERT3, Página 1, o **Hospital do Câncer III – INCA III** informou que a Suplicante está com o exame de **mamografia agendado** para 23 de outubro de 2024, às 13h, no setor de radiologia da própria unidade.

É o parecer.

À 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro - 2º Juiz Relator, da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, para conhecer e tomar as providências que entender cabíveis.

O NAT informou que a parte autora está com o exame de mamografia agendado para 23 de outubro de 2024, às 13h, no setor de radiologia da própria unidade.

Pelo documento acostado no evento 1 - anexo 2, observa-se que a parte autora está sendo atendida no INCA e que houve, após o diagnóstico, a realização de diversos procedimentos médicos para o tratamento da patologia que lhe acomete.

Percebe-se que o diagnóstico ocorreu em 23/03/2021 e que desde então, a parte autora realizou ressecção segmentar de mama em oncologia (23/06/21), quimioterapia do carcinoma (22/07/21) e hormonoterapia do carcinoma (05/07/24).

Do: Instituto Nacional de Câncer
Unidade Hospitalar: HCIII
Clínica: ONCOLOGIA AMBULATORIO HCIII

Para: DIREÇÃO MÉDICA

Informamos que a paciente **SEVERINA ANTONIA PEREIRA** foi matriculada nesta unidade no dia **23/03/2021** com o número **5206191** que esta recebeu os seguintes diagnósticos topográficos:

CID:	Estadiamento	Data
C50.9 - Neoplasia maligna de Mama, não especificada	II A	23/03/2021

:: Tratamentos no INCA

Cirurgias:	Data
RESSECÇÃO SEGMENTAR DE MAMA EM ONCOLOGIA	23/06/2021
Quimioterapias / Hormonioterapias:	Início
QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA EM ESTÁDIO III	22/07/2021
- ACT	
HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA EM ESTÁDIO I	05/07/2024
- anastrozol	

Outros tratamentos:

Portanto, declaramos que a situação atual da paciente é:

Paciente com diagnóstico de carcinoma mamário a esquerda, estadiamento inicial T2N0M0, lobular CLÁSSICO E PLEOMÓRFICO.

CLÍ G2 MAMA ESQUERDA RE 90%, RP 50%, HER 2 neg, Ki67 5% ECI T2N0
> CIRURGIA : RS ME + BLS A ESQUERDA (24/06/2021) pT2 pN0
> QUIMIOTERAPIA : CT ADJUVANTE x4
> RADIOTERAPIA ADJ DE 27/12/2021 - 07/1/2022 - 40Gy
> HORMONIOTERAPIA anastrozol adjuvante. 10/21 - EM CURSO

Exames complementares:
- MMG 26/10/22: CAT 2

impressão: sEGUE HORMONITERAPIA adjuvante

ULTIMA CONSULTA 10/2023 NA ONCOLOGIA, SOLICITADO RETORNO NA MASTOLOGIA COM PREVISÃO 6 MESES.


Médico: RODRIGO MOURA DE ARAUJO CRM: 52696455
Data: 29/07/2024

De tal sorte, a via administrativa está sendo utilizada, estando a parte autora em fila para a realização do exame.

Destarte, não se pode desconsiderar, a priori, a fila de espera já devidamente organizada, sem que haja comprovação de que a autora, de fato, encontra-se em situação pior do que as dos demais, sob pena de se ferir o direito fundamental à saúde dos outros pacientes que ora se encontram aguardando pelo mesmo tratamento pleiteado pela autora.

Assim, em um primeiro momento, entende-se pela ausência do fummus boni juris.

Por essas razões, indefiro a concessão, liminarmente, de efeito suspensivo ativo.

Intimem-se.

Após, à conclusão para voto."

Logo, não estava, ainda, demonstrada a existência de verossimilhança nas alegações e do risco de lesão grave e/ou de difícil reparação, para que pudesse ser concedido efeito suspensivo ativo.

Por tais razões, voto por **CONHECER E NEGAR PROVIMENTO** ao recurso e **ratifico** a decisão que indeferiu a liminar.